

通痹活血汤联合艾灸治疗类风湿关节炎的疗效观察

张咏冬 张小启

(河南省黄河三门峡医院 三门峡 472000)

摘要:目的 探讨通痹活血汤联合艾灸治疗类风湿关节炎的疗效。方法 选取 2023 年 6 月至 2024 年 6 月医院收治的 88 例类风湿关节炎患者为研究对象,按照随机数字表法分为对照组和观察组,各 44 例。对照组采用西药治疗,观察组在对照组基础上加用通痹活血汤联合艾灸治疗,比较两组临床疗效、临床症状积分、实验室指标[C 反应蛋白(CRP)、血沉(ESR)及类风湿因子(RF)]、疾病与健康状况[28 个关节疾病活动指数(DAS28)、健康评估问卷(HAQ)]以及不良反应发生情况。结果 观察组治疗总有效率高于对照组($P<0.05$);观察组治疗后各项临床症状积分均低于对照组($P<0.05$);观察组治疗后 CRP、ESR、RF 水平均低于对照组($P<0.05$);观察组治疗后 DAS28、HAQ 评分均低于对照组($P<0.05$);两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义($P>0.05$)。结论 通痹活血汤联合艾灸治疗类风湿关节炎可有效减轻患者临床症状,抑制疾病活动度,改善患者健康状况,且不会明显增加不良反应。

关键词:类风湿关节炎;通痹活血汤;艾灸;临床症状积分

中图分类号:R593.22

文献标志码:B

doi:10.13638/j.issn.1671-4040.2025.11.016

类风湿关节炎是一种以侵蚀性关节炎为特征的自身免疫疾病,病情较长且难以治愈,以关节肿胀、疼痛、晨僵、畸形等为常见临床表现。若未能得到及时有效的治疗,持续关节炎症会逐步侵蚀关节软骨和骨组织,最终造成关节畸形和功能丧失,严重影响患者日常活动能力及生活质量^[1-2]。西医治疗类风湿关节炎以药物为主,甲氨蝶呤片联合来氟米特片较为常用,虽能在一定程度上缓解患者临床症状,控制病情发展,但长期使用易产生多种副作用,影响治疗效果^[3-4]。中医学将类风湿关节炎归属于“痹症”范畴,认为瘀血痹阻是其主要病机,瘀阻经脉气血,久病入络影响脏腑精气运行,不通则痛,进而引起关节疼痛、肿胀、屈伸不利等症状,治疗应以活血化瘀、通利经络为主要原则。艾灸是一种中医外治疗法,借助艾条燃烧产生的温热效应刺激特定穴位,发挥温经散寒、活血化瘀之功效^[5]。通痹活血汤是由身痛逐瘀汤化裁而来,具有活血化瘀、通络止痛、祛风除湿之功效^[6]。本研究旨在探讨通痹活血汤联合艾灸治疗类风湿关节炎的临床疗效。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2023 年 6 月至 2024 年 6 月医院收治的 88 例类风湿关节炎患者为研究对象,按照随机数字表法分为对照组和观察组,各 44 例。对照组男 18 例,女 26 例;年龄 32~65 岁,平均

(42.35±3.92)岁;体质指数(BMI)18.24~26.87 kg/m²,平均(22.36±1.30) kg/m²;病程 1~10 年,平均(4.68±1.65)年。观察组男 19 例,女 25 例;年龄 34~67 岁,平均(43.10±3.97)岁;BMI 18.31~27.19 kg/m²,平均(22.42±1.36) kg/m²;病程 2~11 年,平均(4.72±1.67)年。两组一般资料比较,差异无统计学意义($P>0.05$)。本研究经医院医学伦理委员会批准(审批号:202305014)。

1.2 入选标准 纳入标准:符合西医诊断标准^[7];中医符合《类风湿关节炎病证结合诊疗指南》^[8]中瘀血痹阻证,具备两项主症(关节刺痛、肿胀、压痛、晨僵)、两项次症(屈伸不利、畸形、皮下结节以及局部皮肤晦暗)及舌脉象(脉沉细涩,舌质紫暗,有瘀斑或瘀点),即可确诊;签署知情同意书。排除标准:合并风湿性、痛风性等其他关节炎性病变;伴有强直性脊柱炎或系统性红斑狼疮;存在精神类疾病或意识障碍;不能耐受本研究治疗方案;处于妊娠期或哺乳期。

1.3 治疗方法 对照组采用西药治疗:予以口服甲氨蝶呤片(国药准字 H20223032),10 mg/次,1 次/周;来氟米特片(国药准字 H20203195),20 mg/次,1 次/d。观察组在对照组基础上加用通痹活血汤联合艾灸治疗。(1)艾灸:取双侧肾俞穴、阿是穴及足三里穴,点燃艾柱,在上述穴位施灸,每个穴位各灸 3 次,以皮肤红晕不起水疱为度,隔日艾灸 1 次。(2)通痹活血

汤:取黄芪、穿山龙各 20 g,当归、川芎、威灵仙、川牛膝各 12 g,桃仁、红花、地龙、香附、秦艽、没药、独活、羌活、乳香各 10 g,五灵脂、甘草各 6 g,加水浸泡,煎煮取汁 400 mL,分早晚温服,1 剂/d,200 mL/次,2 次/d。两组均连续治疗 12 周。

1.4 观察指标 (1) 临床疗效:临床症状积分降低 $\geq 95\%$,为临床控制;临床症状积分降低 70%~94%,为显效;临床症状积分降低 30%~69%,为有效;未达上述标准,为无效。总有效=临床控制+显效+有效。(2) 临床症状积分:治疗前后,根据主症和次症严重程度进行计分,分值越高表示症状越严重。(3) 实验室指标:治疗前后抽取患者空腹静脉血 5 mL,检测 C 反应蛋白(CRP)、血沉(ESR)、类风湿因子(RF)水平。(4) 疾病与健康状况:治疗前后,采用 28 个关节疾病活动指数(DAS28)评估患者疾病活动状况,总分为 10 分,分值越高表示疾病活动度越高;采用健康评估问卷(HAQ),从行走、穿衣、洗漱等维度评估患者健康状况,分值越高表示健康状

况越差。(5) 不良反应:如胃肠道不适、肝肾功能异常、皮疹等。

1.5 统计学方法 数据处理采用 SPSS22.0 统计学软件,计量资料以 $(\bar{x} \pm s)$ 表示,采用 t 检验;计数资料用%表示,采用 χ^2 检验。 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组临床疗效比较 观察组治疗总有效率高

表 1 两组临床疗效比较[例(%)]

组别	n	临床控制	显效	有效	无效	总有效
对照组	44	8(18.18)	16(36.36)	11(25.00)	9(20.45)	35(79.55)
观察组	44	13(29.55)	20(45.45)	10(22.73)	1(2.27)	43(97.73)
χ^2						7.221
P						0.007

2.2 两组临床症状积分比较 观察组治疗后各项临床症状积分均低于对照组,差异有统计学意义($P<0.05$)。见表 2。

表 2 两组临床症状积分比较(分, $\bar{x} \pm s$)

组别	n	关节刺痛		晨僵		关节肿胀		关节压痛	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
对照组	44	4.78 $\pm$ 1.42	2.41 $\pm$ 0.65*	3.98 $\pm$ 1.18	2.62 $\pm$ 0.61*	4.06 $\pm$ 1.17	2.62 $\pm$ 0.62*	3.59 $\pm$ 1.31	2.14 $\pm$ 0.75*
观察组	44	4.75 $\pm$ 1.39	1.12 $\pm$ 0.54*	4.02 $\pm$ 1.20	1.37 $\pm$ 0.57*	4.12 $\pm$ 1.13	1.24 $\pm$ 0.53*	3.56 $\pm$ 1.28	1.03 $\pm$ 0.41*
t		0.100	10.126	0.158	9.932	0.245	11.223	0.109	8.614
P		0.920	<0.001	0.875	<0.001	0.807	<0.001	0.914	<0.001

组别	n	关节畸形		屈伸不利		皮下结节		皮肤晦暗	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
对照组	44	2.04 $\pm$ 0.69	1.17 $\pm$ 0.28*	2.19 $\pm$ 0.64	1.37 $\pm$ 0.52*	2.28 $\pm$ 0.62	1.63 $\pm$ 0.54*	2.22 $\pm$ 0.48	1.46 $\pm$ 0.33*
观察组	44	2.01 $\pm$ 0.62	0.64 $\pm$ 0.15*	2.13 $\pm$ 0.68	0.71 $\pm$ 0.23*	2.25 $\pm$ 0.60	0.76 $\pm$ 0.32*	2.24 $\pm$ 0.49	0.46 $\pm$ 0.12*
t		0.215	11.068	0.426	7.700	0.231	9.194	0.193	18.891
P		0.831	<0.001	0.671	<0.001	0.818	<0.001	0.847	<0.001

注:与同组治疗前比较,* $P<0.05$ 。

2.3 两组实验室指标比较 观察组治疗后 CRP、ESR、RF 水平均低于对照组($P<0.05$)。见表 3。

表 3 两组实验室指标比较($\bar{x} \pm s$)

组别	n	CRP(mg/L)		ESR(mm/h)		RF(IU/mL)	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
对照组	44	30.94 $\pm$ 6.21	16.26 $\pm$ 2.81*	42.35 $\pm$ 7.34	26.78 $\pm$ 4.49*	136.32 $\pm$ 15.16	73.48 $\pm$ 8.37*
观察组	44	31.10 $\pm$ 6.42	8.60 $\pm$ 1.53*	42.88 $\pm$ 7.29	14.43 $\pm$ 2.56*	132.55 $\pm$ 15.69	51.09 $\pm$ 6.05*
t		0.119	15.881	0.340	15.850	1.146	14.381
P		0.906	<0.001	0.735	<0.001	0.255	<0.001

注:与同组治疗前比较,* $P<0.05$ 。

2.4 两组疾病与健康状况比较 观察组治疗后 DAS28、HAQ 评分均低于对照组($P<0.05$)。见表 4。

表 4 两组疾病与健康状况比较(分, $\bar{x} \pm s$)

组别	n	DAS28评分		HAQ 评分	
		治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
对照组	44	4.83± 1.37	2.68± 0.83*	12.29± 2.63	9.09± 1.36*
观察组	44	4.87± 1.39	1.21± 0.50*	12.34± 2.68	5.05± 0.58*
t		0.136	10.063	0.088	18.125
P		0.892	<0.001	0.930	<0.001

注:与同组治疗前比较,* $P<0.05$ 。

2.5 两组不良反应发生情况比较 对照组治疗期间出现胃肠道不适 2 例、皮疹 1 例;观察组出现胃肠道不适和皮疹各 1 例、肝肾功能异常 3 例。对照组不良反应发生率为 6.82% (3/44), 观察组不良反应发生率为 11.36% (5/44), 两组不良反应发生率比较, 差异无统计学意义 ($\chi^2=0.138$, $P=0.711$)。

3 讨论

类风湿关节炎发病机制较为复杂, 可能涉及内分泌、环境、遗传、感染等因素相互作用, 具有病程长且易反复的临床特点, 若治疗不及时, 可导致关节软骨、关节囊等遭到进一步损害, 甚至造成残疾, 严重影响患者机体功能及生活质量^[9]。甲氨蝶呤属于叶酸拮抗剂, 为治疗类风湿关节炎的一线药物, 可通过干扰嘌呤核苷酸和胸腺嘧啶核苷酸合成抑制淋巴细胞增殖, 进而减轻患者体内异常免疫反应, 缓解关节炎症反应。来氟米特则是一种异恶唑类免疫调节剂, 该药活性代谢产物能够阻断嘧啶的从头合成途径, 阻止活化的淋巴细胞合成脱氧核糖核酸 (DNA), 从而抑制淋巴细胞增殖, 还可下调细胞黏附分子的表达, 减少炎症细胞向关节部位迁移、浸润^[10-11]。两者联合应用治疗类风湿关节炎短期内效果较为显著, 但长期应用极易产生恶心、呕吐等副作用, 降低治疗效果。

中医学认为, 类风湿关节炎主要因正气不足, 感受外邪, 导致经络痹阻, 气血运行不畅而发病。《素问·痹论》中记载:“风寒湿三气杂至, 合而为痹也。”风、寒、湿 3 种邪气侵袭人体, 相互搏结, 闭阻经络气血而引发痹症。本研究结果显示, 观察组治疗总有效率高于对照组 ($P<0.05$); 观察组治疗后各项临床症状积分均低于对照组 ($P<0.05$); 观察组治疗后 CRP、ESR、RF 水平均低于对照组 ($P<0.05$); 观察组治疗后 DAS28、HAQ 评分均低于对照组 ($P<0.05$);

两组不良反应发生率比较, 差异无统计学意义 ($P>0.05$)。这提示通痹活血汤联合艾灸治疗类风湿关节炎效果显著, 利于减轻患者临床症状, 抑制疾病活动度, 改善患者健康状况, 且安全性较高。艾灸通过燃烧艾炷, 在肾俞穴、阿是穴以及足三里穴施灸, 其中肾俞穴具有补肾益精之功效; 阿是穴具有调节气血、舒筋活络之功效; 足三里穴具有补中益气、通经活络之功效。艾炷燃烧产生的温热刺激可激发经络之气, 调节脏腑功能, 促进气血运行, 进而达到温通经络、散寒除湿、调和气血之功效^[12]。现代医学研究结果表明^[13], 艾灸通过温热刺激穴位, 能够调节免疫细胞活性, 抑制炎症介质产生, 进而减轻关节炎症。通痹活血汤方中秦艽、羌活、独活为君药, 秦艽具有舒筋止痛、活血化瘀之功效, 羌活具有舒筋活络、祛风除湿之功效, 独活具有祛风除湿、通痹止痛之功效。当归、川芎、桃仁、红花、乳香、没药共为臣药, 当归具有补血调经、缓解疼痛之功效, 川芎具有活血行气、祛风止痛之功效, 桃仁及红花具有活血调经、散瘀止痛之功效; 乳香具有消肿生肌、活血定痛之功效, 没药具有散瘀定痛之功效。黄芪、牛膝、地龙、五灵脂、威灵仙共为佐药, 黄芪具有补气养血、利尿消肿之功效, 牛膝具有引血下行之功效, 地龙具有搜风通络之功效, 五灵脂具有活血化瘀、行血止痛、消积解毒之功效, 威灵仙具有祛风湿、通经络之功效。香附、甘草为使药, 调和诸药。诸药合用, 可使正胜邪退, 瘀血得化, 疼痛得消^[14]。现代药理学研究表明^[15], 通痹活血汤方中当归、秦艽、黄芪、川芎等药材具有抗炎、免疫调节作用, 当归中的水溶性成分阿魏酸能够清除氧自由基, 抑制炎症反应, 减轻关节组织损伤; 秦艽能够抑制 T 淋巴细胞增殖和活化, 减少免疫球蛋白和细胞因子分泌, 纠正异常免疫应答, 进而减轻免疫攻击对关节组织的破坏; 黄芪中的有效成分黄芪多糖、黄酮类等能够促进免疫球蛋白分泌, 调节免疫功能, 抑制促炎细胞因子释放; 川芎中的活性成分川芎嗪能抑制中性粒细胞趋化和黏附, 减少炎症细胞在关节滑膜浸润, 进而抑制炎症介质产生, 减轻炎症损伤; 桃仁中的有效成分苦杏仁苷具有抗凝作用, 可抑制血栓形成, 进而使关节部位血液循环通畅, 改善局部组织缺血、缺氧状况, 减轻关节(下转第 59 页)

像,能够更高效地分离血管和胆管,避免误伤重要的胆管结构和血管,减少术中出血量,为患者病情恢复提供有利条件^[14-15]。本研究中,研究组肝门阻断时间缩短,但手术总时间并未明显减少,可能与手术 ICG 染色用时和病例数较少与有关。

综上所述,ICG 引导辅助 LAH 利于缩短肝门阻断时间,减少术中出血量,降低手术操作对肝功能的不利影响,助力医生精准识别并最大限度地保留健康的肝组织,为患者术后肝功能恢复及整体康复创造有利条件。

参考文献

- [1]陈磊,唐彤,张代忠,等.精准肝蒂解剖技术辅助腹腔镜肝癌切除术的效果及对炎症免疫应激、肝功能的影响[J].昆明医科大学学报,2024,45(4):120-127.
- [2]王晓颖.腹腔镜解剖性肝切除术中荧光染色意外及对策[J].中国实用外科杂志,2022,42(9):1001-1004.
- [3]程东辉,杨冲,蒋佑朋,等.超声引导下经皮经肝注射吲哚菁绿与声诺维混合剂在腹腔镜肝锥形单元切除中的应用研究[J].中国实用外科杂志,2024,44(2):211-215,223.
- [4]肖亮,谭盛,米星宇,等.三维可视化技术联合荷瘤门静脉流域分析在腹腔镜解剖性肝切除中的应用[J].中国普通外科杂志,2023,32(1):30-39.
- [5]李淑敏,李梦蕾,千贝贝.吲哚菁绿荧光导航腹腔镜解剖性肺段切除术治疗早期非小细胞肺癌的临床观察[J].实用中西医结合临床,2024,24(20):78-81,100.

- [6]中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院消化道肿瘤多学科协作组.肝癌靶向治疗专家共识(草案)[J].肝癌电子杂志,2020,7(2):2-11.
- [7]吴景辉,王雪梅,典风丽,等.腹腔镜下解剖性肝切除术对原发性肝癌患者炎症因子、肝功能的影响[J].癌症进展,2023,21(4):384-387.
- [8]凌福生,连志刚,游恩龙,等.基于倾向评分匹配法比较开腹肝切除术与腹腔镜下肝静脉导向解剖性肝切除术治疗左外叶肝细胞瘤的效果[J].广西医学,2023,45(14):1658-1663.
- [9]季鹏,孟凡征,张瑜瑜,等.经皮微波消融与腹腔镜下解剖性肝切除治疗直径 ≤ 3 cm 原发肝癌的疗效分析[J].肝胆外科杂志,2024,32(6):438-444.
- [10]赖子森,吕嘉晖,刘广文,等.超声引导下经皮经肝门静脉穿刺注射吲哚菁绿在腹腔镜解剖性肝切除术中的应用价值[J].中华消化外科杂志,2024,23(12):1544-1549.
- [11]刘凌,肖瑶,盛朗晴,等.腹腔镜下鞘外解剖性肝切除结合 ICG 荧光反染在肝胆管结石治疗中的应用(附视频)[J].中国普通外科杂志,2023,32(8):1218-1228.
- [12]钟莹,吴昊钧,谭颖,等.吲哚菁绿荧光成像在复杂腹腔镜胆囊切除术中的应用[J].腹腔镜外科杂志,2024,29(8):602-606.
- [13]王之浩,姚明军,斯琴塔娜,等.吲哚菁绿荧光显像技术在腹腔镜肝切除中的应用[J].肝胆外科杂志,2022,30(5):388-390.
- [14]俞帆,金丽明,刘杰,等.吲哚菁绿荧光导航在日间腹腔镜胆囊切除术中的临床应用价值[J].中国普通外科杂志,2024,33(2):236-243.
- [15]张东,方宏才.吲哚菁绿荧光融合影像引导下背头尾侧联合入路腹腔镜解剖性左半肝切除术的临床应用[J].肝胆胰外科杂志,2023,35(6):353-356,365.

(收稿日期: 2025-01-10)

(上接第 55 页) 损伤;红花中的有效成分红花黄色素能降低血液凝固性,预防血栓形成,维持关节周围血管的正常功能。综上所述,通痹活血汤联合艾灸治疗类风湿关节炎可有效减轻患者临床症状,抑制疾病活动度,改善患者健康状况,且不会明显增加不良反应。

参考文献

- [1]贾需雯,杨迎,邹耀威,等.类风湿关节炎患者低肌肉量综合征的临床特征及其对躯体功能的影响[J].北京大学学报(医学版),2024,56(6):1009-1016.
- [2]赵文娟,常志芳,赵剑波,等.1 061 例类风湿关节炎患者骨密度及相关危险因素分析[J].中国骨质疏松杂志,2022,28(9):1321-1325,1335.
- [3]全瑛,王蓉,顾天欣,等.通痹祛瘀散外敷联合甲氨蝶呤对类风湿关节炎患者的治疗效果[J].实用中西医结合临床,2023,23(4):102-105.
- [4]秦桂福,李惠玲,叶志勤,等.益肾除痹方联合来氟米特片治疗老年类风湿关节炎疗效观察[J].现代中西医结合杂志,2020,29(4):395-398.
- [5]柏林康,梁慧,王文娟,等.艾灸联合西药治疗瘀血痹阻型类风湿关节炎及对血小板活化的影响[J].中国针灸,2023,43(8):927-931.
- [6]丁超儿,周志华,计少华.补肾活血通痹汤联合针刺肾俞穴治疗脾胃阳虚型老年骨质疏松症临床研究[J].新中医,2022,54(13):88-92.

- [7]风湿免疫疾病慢病管理全国护理协作组.类风湿关节炎患者的慢病管理专家共识(2014 版)[J].中华风湿病学杂志,2016,20(2):127-131.
- [8]中华中医药学会风湿病分会.类风湿关节炎病证结合诊疗指南[J].中医杂志,2018,59(20):1794-1800.
- [9]何志翔,蔡小燕,林小军,等.老年类风湿关节炎合并肌少症患者骨密度及骨代谢指标改变的临床研究[J].中国骨质疏松杂志,2022,28(3):403-406,425.
- [10]刘朝民.老年中重度类风湿关节炎患者中枸橼酸托法替布联合甲氨蝶呤的疗效分析[J].吉林医学,2023,44(2):426-428.
- [11]李树岗,宋远瑛.皂芥二陈汤联合来氟米特治疗痰瘀痹阻证类风湿关节炎疗效及对血清 IL-33、BMP-2、GM-CSF 的影响[J].现代中西医结合杂志,2021,30(4):403-407.
- [12]唐洁,武平,余泽芸,等.艾灸对类风湿关节炎患者血清中白三烯 B₄、基质金属蛋白酶-9 的影响[J].针刺研究,2023,48(5):488-493.
- [13]袁婷,徐妮妮,范雪燕,等.艾灸干预类风湿关节炎护理操作关键点研究报告现状分析[J].护理学报,2023,30(5):47-52.
- [14]周志航,王建国,丁厚鹏.活血通痹汤联合富血小板血浆治疗膝骨性关节炎 54 例[J].中国中医骨伤科杂志,2022,30(1):61-64.
- [15]桂珣,龚国星,黄芬梅,等.补肾活血通痹汤对老年骨质疏松症患者骨密度及骨代谢指标的影响[J].中国医学创新,2023,20(11):66-69.

(收稿日期: 2024-12-26)